

**INFORMACIÓN GENERAL**

Fecha de Impresión: 07/09/2026 15:57

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: AS VEN21163875 - GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

Fecha de Nacimiento: 29/07/1992

Religión:

Régimen: 3 - Vinculado

Dirección: BARRIO LA ESPERANZA CALLE BENJAMIN HERRERA 34-122

Teléfono:

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO

OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: MARCOS GONZALEZ

Teléfono Acomp.: 3136562742

Dirección Acomp.: MSMA DIRECCION

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Fecha de Atención: 26/04/2022 12:31

Admisión: AD716477

Edad: 29 año(s), 8 mes(es) 28 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: PAREJA

Especialidad: INFECTOLOGIA

Impreso por: Pinvestigacion

Sexo: F

Estado Civil: Unión Libre

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS**DATOS DE LA CONSULTA**

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 22/02/2022 10:04

Cama: 4--14

Motivo de la Consulta:

"TENGO FIEBRE, DOLOR EN EL CUERPO Y TOS "

ANTECEDENTES:

* 1-> DESCRITO

* 2-> NIEGA

* 5-> NIEGA ALERGIAS, NIEGA TOXICOS

* 6-> NIEGA DE CONTROL

* 9-> VACUNA CONTRA SARS COV2 (1 DOSIS AZTRAZENECA)

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE SIN APARENTE PATOLOGIAS DE BASE, QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 1 MES DE EVOLUCION QUE SE AGUDIZADO EN LA ULTIMA SEMANA CONSISTENTE EN PRESENTAR TOS CON ESPECTORACION BLANQUECINA EN OCASIONES VERDOSA QUE SE ASOCIA A FIEBRE NO CUANTIFICADA, INTERMITENTE, VOMITOS DE CONTENIDO ALIMENTARIO, ASTENIA, HIPOREXIA, ADEMAS ACUSA PERDIDA DE PESO ESTIMADO EN (8 KG EN UN MES). NIEGA ODINOFAGIA, NIEGA DISNEA, NIEGA DOLOR PLEURITICO, NIEGA ANOSMIA, NIEGA AGEUSIA, NIEGA DIARREA, NIEGA CONTACTO CON PERSONAS SOSPECHOSAS E INFECTADAS POR COVID- 19.

SATURACION DE OXIGENO AL INGRESO 98 % AIRE AMBIENTE.

SE ATIENDE CON MEDIOS DE PROTECCION POR PANDEMIA ACTUAL.

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, EL CUAL SE REINICIO Y HASTA EL MOMENTO CON BUENA TOLERANCIA, SE DECIDIÓ NO INICIO DE ISONIAZIDA Y SE INDICÓ LEVOFLOXACINA, EN EL MOMENTO CON ADECUADA TOLERANCIA. PARA CLÍNICOS DE CONTROL DENTRO DE LÍMITES ACEPTABLES, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA GANGLIOS CERVICALES IZQUIERDOS, EL CUAL PROBABLMENTE SERÁ REALIZADO EL 25/04/2022. POR EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE. SE SOLICITA BRONCOSCOPIA POR ADENOMEGALIAS CERVICALES EN ESTUDIO Y LESIONES SUBPLEURALES. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS.

Revisión Por Sistema:

RESPIRATORIO

EXAMEN FISICO:**Apariencia a su llegada:**

INGRESA DEAMBULANDO POR SUS MEDIOS, EN REGULAR ESTADO NUTRICIONAL Y GENERAL, CONSCIENTE, ORIENTADA EN SUS TRES ESFERAS.

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTERICAS, NARIZ: FOSAS NASALES PERMEABLES, BOCA: MUCOSA ORAL HUMEDA SIN ALTERACIONES, CUELLO SIMETRICO MOVIL SE PALPAN ADENOPATIAS, NO INJURGITACION YUGULAR, NO RIGIDEZ DE NUCA.

Tórax:

SIMETRICO EXPANSIBLE SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL DISMINUIDO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS.

Abdomen:

PLANO BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, PUÑO PERCUSION RENAL NEGATIVA.

Piel y faneras:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

SIN ALTERACIONES

Genito-Urinario:

NO EXPLORADOS

Extremidades:

SIMÉTRICAS, HIPOTROFICAS, SIN EDEMA, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS, LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.

Sistema nervioso central:

GLASGOW 15 / 15

Análisis:

PACIENTE SIN APARENTE PATOLOGÍAS DE BASE, QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE 1 MES DE EVOLUCIÓN QUE SE AGUDIZADO EN LA ÚLTIMA SEMANA CONSISTENTE EN PRESENTAR TOS CON ESPECTORACIÓN BLANQUECINA EN OCASIONES VERDOSA QUE SE ASOCIA A FIEBRE NO CUANTIFICADA, INTERMITENTE, VÓMITOS DE CONTENIDO ALIMENTARIO, ASTENIA, HIPOREXIA, ADEMÁS ACUSA PERDIDA DE PESO ESTIMADO EN (8 KG EN UN MES). NIEGA ODINOFAGIA, NIEGA DISNEA, NIEGA DOLOR PLEURÍTICO, NIEGA ANOSMIA, NIEGA AGEUSIA, NIEGA DIARREA, NIEGA CONTACTO CON PERSONAS SOSPECHOSAS E INFECTADAS POR COVID- 19.

SATURACIÓN DE OXÍGENO AL INGRESO 98 % AIRE AMBIENTE.

SE ATIENDE CON MEDIOS DE PROTECCIÓN POR PANDEMIA ACTUAL.

PACIENTE SINTOMÁTICA RESPIRATORIA, QUIEN CURSA CON SÍNDROME CONSTITUCIONAL, AL INGRESO CON CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA HIPOTENSION, EUCÁRDICA, EUPNEICA, SATURACIÓN EN METAS, CONSIDERANDO LO ANTERIOR SE ORDENA MANEJO, PARACLÍNICOS, VALORACIÓN CON RESULTADOS PARA DETERMINAR CONDUCTA A SEGUIR.

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:**Diagnóstico Principal:** J22X : INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES**Diagnóstico Relacionado 1:** Z030 : OBSERVACIÓN POR SOSPECHA DE TUBERCULOSIS**EVOLUCIONES:**

Fecha: 22/02/2022: 13:03:00, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: YISELA TOVAR DEL RIO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: REPORTE DE PARACLÍNICOS

Descripción: PACIENTE SIN APARENTE PATOLOGÍAS DE BASE, QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE 1 MES DE EVOLUCIÓN QUE SE AGUDIZADO EN LA ÚLTIMA SEMANA CONSISTENTE EN PRESENTAR TOS CON ESPECTORACIÓN BLANQUECINA EN OCASIONES VERDOSA QUE SE ASOCIA A FIEBRE NO CUANTIFICADA, INTERMITENTE, VÓMITOS DE CONTENIDO ALIMENTARIO, ASTENIA, HIPOREXIA, ADEMÁS ACUSA PERDIDA DE PESO ESTIMADO EN (8 KG EN UN MES). NIEGA ODINOFAGIA, NIEGA DISNEA, NIEGA DOLOR PLEURÍTICO, NIEGA ANOSMIA, NIEGA AGEUSIA, NIEGA DIARREA, NIEGA CONTACTO CON PERSONAS SOSPECHOSAS E INFECTADAS POR COVID- 19. SATURACIÓN DE OXÍGENO AL INGRESO 98 % AIRE AMBIENTE. SE ATIENDE CON MEDIOS DE PROTECCIÓN POR PANDEMIA ACTUAL. PACIENTE SINTOMÁTICA RESPIRATORIA, QUIEN CURSA CON SÍNDROME CONSTITUCIONAL, AL INGRESO CON CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA HIPOTENSION, EUCÁRDICA, EUPNEICA, SATURACIÓN EN METAS, CONSIDERANDO LO ANTERIOR SE ORDENA MANEJO, PARACLÍNICOS, VALORACIÓN CON RESULTADOS PARA DETERMINAR CONDUCTA A SEGUIR. SE RECIBE REPORTE DE PARACLÍNICOS : GLICEMIA 114, BUN 11, CREATININA 0.79, B DIRECTA 0.2, POTASIO 4.1, CLORO 99, SODIO 132, ALT 19, AST 340, HEMOGRAMA (LEUCO 5.42, NEUTRO 67.7, LINF 20.6, HB 6.9, HTO 24.3, RTO DE PLAQUETAS 307, VIH 1 Y 2 POSITIVO, ANTIGENO PARA SARS COV2 NEGATIVO. PENDIENTE BACILOCOPIA, UROANÁLISIS, RX DE TORAX PA Y LATERAL. CONSIDERANDO LO ANTERIOR REPORTE DE HEMOGRAMA SIN LEUCOCITOSIS, NO NEUTROFILIA, ANEMIA SEVERA, NO TROMBOCITOPENIA, FUNCIÓN HEPÁTICA CONSERVADA, FUNCIÓN RENAL CONSERVADA, HIPONATREMIA LEVE, GLICEMIA EN METAS, SEROLOGÍA VIH POSITIVA, SE DESCARTA INFECCIÓN POR COVID - 19. SE DETERMINA ORDENAR PRUEBA CONFIRMATORIA VIH, RESERVAR UD DE GRE Y VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA.

Fecha: 22/02/2022: 13:03:01, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: YISELA TOVAR DEL RIO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: REPORTE DE PARACLÍNICOS

Descripción: PACIENTE SIN APARENTE PATOLOGÍAS DE BASE, QUIEN INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE 1 MES DE EVOLUCIÓN QUE SE AGUDIZADO EN LA ÚLTIMA SEMANA CONSISTENTE EN PRESENTAR TOS CON ESPECTORACIÓN BLANQUECINA EN OCASIONES VERDOSA QUE SE ASOCIA A FIEBRE NO CUANTIFICADA, INTERMITENTE, VÓMITOS DE CONTENIDO ALIMENTARIO, ASTENIA, HIPOREXIA, ADEMÁS ACUSA PERDIDA DE PESO ESTIMADO EN (8 KG EN UN MES). NIEGA ODINOFAGIA, NIEGA DISNEA, NIEGA DOLOR PLEURÍTICO, NIEGA ANOSMIA, NIEGA AGEUSIA, NIEGA DIARREA, NIEGA CONTACTO CON PERSONAS SOSPECHOSAS E INFECTADAS POR COVID- 19. SATURACIÓN DE OXÍGENO AL INGRESO 98 % AIRE AMBIENTE. SE ATIENDE CON MEDIOS DE PROTECCIÓN POR PANDEMIA ACTUAL. PACIENTE SINTOMÁTICA RESPIRATORIA, QUIEN CURSA CON SÍNDROME CONSTITUCIONAL, AL INGRESO CON CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA HIPOTENSION, EUCÁRDICA, EUPNEICA, SATURACIÓN EN METAS, CONSIDERANDO LO ANTERIOR SE ORDENA MANEJO, PARACLÍNICOS, VALORACIÓN CON RESULTADOS PARA DETERMINAR CONDUCTA A SEGUIR. SE RECIBE REPORTE DE PARACLÍNICOS : GLICEMIA 114, BUN 11, CREATININA 0.79, B DIRECTA 0.2, POTASIO 4.1, CLORO 99, SODIO 132, ALT 19, AST 340, HEMOGRAMA (LEUCO 5.42, NEUTRO 67.7, LINF 20.6, HB 6.9, HTO 24.3, RTO DE PLAQUETAS 307, VIH 1 Y 2 POSITIVO, ANTIGENO PARA SARS COV2 NEGATIVO. PENDIENTE BACILOCOPIA, UROANÁLISIS, RX DE TORAX PA Y LATERAL. CONSIDERANDO LO ANTERIOR REPORTE DE HEMOGRAMA SIN LEUCOCITOSIS, NO NEUTROFILIA, ANEMIA SEVERA, NO TROMBOCITOPENIA, FUNCIÓN HEPÁTICA CONSERVADA, FUNCIÓN RENAL CONSERVADA, HIPONATREMIA LEVE, GLICEMIA EN METAS, SEROLOGÍA VIH POSITIVA, SE DESCARTA INFECCIÓN POR COVID - 19. SE DETERMINA ORDENAR PRUEBA CONFIRMATORIA VIH, RESERVAR UD DE GRE Y VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA.

Fecha: 23/02/2022: 10:47:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

1. VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA DE NOVO

2. SME CONSTITUCIONAL

3. SME ANÉMICO SEVERO

4. SINTOMÁTICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR:

4.1 TB PULMONAR ¿?

4.2 NEUMONIA ¿?

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE MEJOR

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:100/60 MMHG FC: 120 LPM FR: 18 RPM SAO2: 99% AL 21%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 22/02/22: AB+ BASILOCOPIA MUESTRA #1: NO SE OBSERVA BAAR NA:132 CL:99 K:4,1 BUN:11 CREA:0,79 AST:34 ALT:19 BD:0,2 LEU:5,42 NEU:67,7 LINF:20,6 HB:6,9 HTO:24,3 VCM:77,3 HCM:21,3 PLT:307 UROANALISIS:AMARILLO, TURBIO, D:1030 PH:5,5 SAMGRE:80 NITRITOS: NEG, LEU:NEH CE:5.10XC LEU:5.10XC HEM:10-15XC BACTERIAS:++ SARS COVID: NEGATIVO HIV 1 Y 2 ANTICUERPOS: POSITIVO

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXAMEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, TAQUICARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVICULARES, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. SE REPORTAN PARACLINICOS, EVIDENCIANDO ANEMIA SEVERA, SARS COVID NEGATIVO, PERFIL HEPATICO Y FUNCION RENAL SIN ALTERACIONES. ANTICUERPOS HIV 1 Y 2 POSITIVOS. EL DIA DE HOY SE DECIDE SOLICITAR SEGUNDO ELISA (VIH CONFIRMATORIA), PERFIL FERROCINETICO, VITAMINA B 12, ACIDO FOLICO, ALT, AST, BILIRRUBINAS, ANTIGENO SUP. HEPATITIS B, CMV IGG E IGM, HERPES VIRUS 1 Y 2, VDRL, COOMBS DIRECTO, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES Y CONTINUAMOS PENDIENTE DE REPORTE DE PARACLINICOS Y ECOGRAFIA DE ABDOMEN. PACIENTE A LA CUAL SE LE TRANSFUNDE 1 UGUE Y SE REPORTA HEMOGLOBINA CONTROL EN 8. PACIENTE CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO BICONJUGADO INSTAURADO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 24/02/2022: 12:05:37, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA DE NOVO
2. SME CONSTITUCIONAL
3. SME ANEMICO SEVERO
4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR:
- 4.1 TB PULMONAR ¿?
- 4.2 NEUMONIA ¿?

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE MEJOR

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:90/50 MMHG FC: 92 LPM FR: 19 RPM SAO2: 99% AL 21%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 23/02/22 VIH 1Y2: POSITIVO VDRL: NO REACTIVO LEU: 4,72 NEU: 3,21 LINF: 1,00 HB: 8 HTO: 27,7 VCM: 79 HCM: 22,9 PLT: 275

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXAMEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, TAQUICARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVICULARES, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. SE REPORTAN PARACLINICOS, EVIDENCIANDO ANEMIA SEVERA, SARS COVID NEGATIVO, PERFIL HEPATICO Y FUNCION RENAL SIN ALTERACIONES. ANTICUERPOS HIV 1 Y 2 POSITIVOS. EL DIA DE HOY SE RECIBE REPORTE DE SEGUNDO ELISA CON RESULTADO POSITIVO (VIH CONFIRMADA), Y HEMOGRAMA CON EVIDENCIA DE ANEMIA MODERADA. SE SOLICITA FIBROBRONCOSCOPIA, CON LAVADO BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL FERROCINETICO, PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL Y CONTEO DE CD4, VDRL, HEPATITIS C TOXOPLASMA IGM E IGG, VITAMINA B 12, ACIDO FOLICO, ALT, AST, BILIRRUBINAS, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES Y ECOGRAFIA DE ABDOMEN. PACIENTE CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO BICONJUGADO INSTAURADO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 25/02/2022: 10:43:07, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA DE NOVO
2. SME CONSTITUCIONAL
3. SME ANEMICO SEVERO
4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR:
- 4.1 TB PULMONAR ¿?
- 4.2 NEUMONIA ¿?

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE MEJOR

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:100/60 MMHG FC: 114 LPM FR: 20 RPM SAO2: 99% AL 21% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARACLINICOS: 24/02/22 LEU 5.22 NEU 71.0 LINF 17.15 ABS 0.93 HTO 26.4 VCM 79 HCM 29 HB 7.9 PLT 294 ESP HIPOCROMIA ++ MICROCITOS + MACROCITOS + ANULOCITOS ++ ESTOMATOCITOS + RETICULOCITOS 1.6 % SATURACION DE TRANSFERRINA 10.35 HIERRO 21 FERITINA 392

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXAMEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, TAQUICARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVICULARES, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. SE REPORTAN PARACLINICOS, EVIDENCIANDO ANEMIA SEVERA, SARS COVID NEGATIVO, PERFIL HEPATICO Y FUNCION RENAL SIN ALTERACIONES. ANTICUERPOS HIV 1 Y 2 POSITIVOS. EL DIA DE HOY SE RECIBE REPORTE DE PARACLINICOS QUE REPORTAN ANEMIA HIPOCROMICA MICROCITICA GRANULOCITICA A EXPENSAS DE DEFICIENCIA FERRICA. SE SOLICITA VALORACION POR TRABAJO SOCIAL. QUEDAMOS PENDIENTES A REPORTE DE FIBROBRONCOSCOPIA, CON LAVADO BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL Y CONTEO DE CD4, VDRL, HEPATITIS C TOXOPLASMA IGM E IGG, VITAMINA B 12, ACIDO FOLICO, ALT, AST, BILIRRUBINAS, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES Y ECOGRAFIA DE ABDOMEN. PACIENTE CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO BICONJUGADO INSTAURADO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Fecha: 26/02/2022: 10:24:08, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA DE NOVO 2. SME CONSTITUCIONAL 3. SME ANEMICO SEVERO 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TB PULMONAR ¿? 4.2 NEUMONIA ¿?

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:100/60 MMHG FC: 114 LPM FR: 20 RPM SAO2: 99% AL 21% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOMBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, TAQUICARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. SE REPORTAN PARACLINICOS, EVIDENCIANDO ANEMIA SEVERA, SARS COVID NEGATIVO, PERFIL HEPATICO Y FUNCION RENAL SIN ALTERACIONES. ANTICUERPOS HIV 1 Y 2 POSITIVOS. SE SOLICITA VALORACION POR TRABAJO SOCIAL. QUEDAMOS PENDIENTES A REPORTE DE FIBROBROSCOPIA, CON LAVADO BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL Y CONTEO DE CD4, VDRL, HEPATITIS C TOXOPLASMA IGM E IGG, VITAMINA B 12, ACIDO FOLICO, ALT, AST, BILIRRUBINAS, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES Y ECOGRAFIA DE ABDOMEN. PACIENTE CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO BICONJUGADO INSTAURADO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 27/02/2022: 11:02:29, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME COSNTTUCIONAL
3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022
4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR:
4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR
4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:110/60 MMHG FC: 94 LPM FR: 20 RPM SAO2: 96% AL 21% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOMBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, TAQUICARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EL DIA DE HOY SE RECIBE REPORTE DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN LA CUAL REPORTA HEPATOSPLENOMEGALIA, TOXOPLASMA IGG 13.3, IGM 0.3, TCD4: 267 ACTUALMENTE CONTINUAMOS PENDIENTE A VALORACION POR TRABAJO SOCIAL, REPORTE DE FIBROBROSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL, VDRL, HEPATITIS C, VITAMINA B 12, ACIDO FOLICO, ALT, AST, BILIRRUBINAS, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES. PACIENTE CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO BICONJUGADO INSTAURADO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 28/02/2022: 11:07:02, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME COSNTTUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:110/80 MMHG FC: 112 LPM FR: 18 RPM SAO2: 99% AL 21% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOMBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, TAQUICARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EL DIA DE HOY SE SUSPENDE MANEJO CON CLARITROMICINA SE SOLICITA LDH. PACIENTE QUIEN SE ECNUETRA RECIBIENDO TERAPIA RIPE EN D1. ACTUALMENTE CONTINUAMOS PENDIENTE A VALORACION POR TRABAJO SOCIAL, REPORTE DE FIBROBROSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL, VDRL, HEPATITIS C, VITAMINA B 12, ACIDO FOLICO, ALT, AST, BILIRRUBINAS, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES. PACIENTE CONTINUA CON MANEJO ANTIBIOTICO BICONJUGADO INSTAURADO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Fecha: 01/03/2022: 11:11:58, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME COSNTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MCROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: TA:100/60 MMHG FC: 70 LPM FR: 20 RPM SAO2: 96% AL 21% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE TIENE PENDIENTE REPORTE DE LDH VALORACION POR TRABAJO SOCIAL Y REPORTE DE FIBROBRONCOSCOPIA CON LAVADO, BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CUENTA CON NIVELES DE VTAMINA B12 DENTRO DE LIMITES NORMALES CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL, VDRL, HEPATITIS C, ACIDO FOLICO, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES. PACIENTE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO SIN EMBARGO SE SOLICITA PARA CLINICOS DE DE CONTROL DADOS POR HEMOGRAMA, IONOGRAMA Y TRANSAMINASAS PARA DEFINIR CONDUCTA. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 02/03/2022: 10:05:37, Historia: Notas, Prestador: ELVIRA CRISTINA DIAZ RAMIREZ, Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Asunto: RESPUESTA DE INTERCONSULTA

Descripción: PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD EN SEGUIMIENTO POR TRABAJO SOCIAL.

SE ESTABLECE ENTREVISTA

CON PACIENTE QUIEN REFIERE QUE ES MIGRANTE DE ORIGEN VENEZOLANA EN

SITUACIÓN IRREGULAR, NO CUENTA CON PERMISO DE PROTECCIÓN TEMPORAL O SALVOCONDUCTO, EN PACIENTE SIN ACOMPAÑANTE, NO HA SIDO POSIBLE CONTACTAR A FAMILIARES PARA ORIENTAR SOBRE RUTA INSTITUCIONAL PERTINENTE, PARA REGULAR ESTANCIA EN EL PAÍS Y POSTERIOR ASEGURAMIENTO EN SALUD. SE INDICAN RECOMENDACIONES A LA PACIENTE. SE REALIZA ABORDAJE CON EL OBJETIVO DE:

BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL

ORIENTACIÓN RESPECTO A

RUTA INSTITUCIONAL PERTINENTE.

HERRAMIENTAS PARA

AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

PROMOVER PAUTAS DE

CUIDADO - AUTOCUIDADO, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. CONTINUA EN SEGUIMIENTO.

Fecha: 02/03/2022: 13:17:04, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO VEGA SALAZAR, Especialidad: ANESTESIOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICO:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME COSNTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MCROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA NAUSEAS, NO VOMITO, NIEGA OTROS SINTOMAS.

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE TIENE PENDIENTE REPORTE DE LDH VALORACION POR TRABAJO SOCIAL Y REPORTE DE FIBROBRONCOSCOPIA CON LAVADO, BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CUENTA CON NIVELES DE VTAMINA B12 DENTRO DE LIMITES NORMALES CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL, VDRL, HEPATITIS C, ACIDO FOLICO, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES. PACIENTE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 03/03/2022: 12:15:24, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICO: 1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME COSNTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MCROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE TIENE PENDIENTE REPORTE DE LDH VALORACION POR TRABAJO SOCIAL Y REPORTE DE FIBROBRONCOSCOPIA CON LAVADO, BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CUENTA CON NIVELES DE VITAMINA B12 DENTRO DE LIMITES NORMALES CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL, VDRL, HEPATITIS C, ACIDO FOLICO, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES. PACIENTE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTAA SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 04/03/2022: 11:49:51, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME COSNTITUCIONAL
3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022
4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR:
- 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR
- 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

ULTIMOS LABORATORIOS:

04/03/2022:

HEPATITIS B ANTIGENO: NEGATIVO

02/03/2022

AST 82, ALT 57, BT 0.49, BD 0.1,

01/03/2022

HB:9.1, LEU:5.35, NEUT:62.3, LINF:20.7, HTO:32.6, PLAQ:338, CLORO:98, POTASIO:3.9, SODIO:131

Análisis:

NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE, TIENE PENDIENTE REPORTE DE LDH VALORACION POR TRABAJO SOCIAL Y REPORTE DE FIBROBRONCOSCOPIA CON LAVADO, BRONCOALVEOLAR Y GENEXPER. CUENTA CON NIVELES DE VITAMINA B12 DENTRO DE LIMITES NORMALES CONTINUAMOS PENDIENTE A REPORTE DE PERFIL INFECCIOSO, CARGA VIRAL, VDRL, HEPATITIS A, ACIDO FOLICO, RETICULOCITOS, COPROLOGICO SERIADO, COPROCULTIVO, SANGRE OCULTA EN HECES. PACIENTE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO. SE LE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 05/03/2022: 12:55:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME COSNTITUCIONAL
3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022
4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR:
- 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR
- 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE.

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXMAEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE, RESULTADO DE HEPATITIS B NEGATIVO. VDRL NEGATIVO. TIENE PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA MAS LAVADO BRONQUIALVEOLAR GENEXPERT SOLICITADO DESDE EL 02/03/22, CARGA VIRAL. CONTINUAMOS ESPERANDO VALORACION POR TRABAJO SOCIAL. EN EL MOMENTO PACIENTE CON EVIDENTE MEJORIA CLINICA EN CUANTO A FECHA DE INGRESO. SE LE INFORMA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTAA SEGUIR A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 06/03/2022: 11:33:01, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME COSNTITUCIONAL
3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMEINTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE DOLOR EN EL PECHO, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGÍA NUEVA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXAMEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE, RESULTADO DE HEPATITIS B NEGATIVO. VDRL NEGATIVO. TIENE PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA MAS LAVADO BRONQUIALVEOLAR GENEXPERT SOLICITADO DESDE EL 02/03/22, CARGA VIRAL. CONTINUAMOS ESPERANDO VALORACION POR TRABAJO SOCIAL. SE SOLICITA HEMOGRAMA, IONOGRAMA, TRANSAMINASAS DE CONTROL. EN EL MOMENTO PACIENTE CON EVIDENTE MEJORIA CLINICA EN CUANTO A FECHA DE INGRESO. SE LE INFORMA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 07/03/2022: 11:56:02, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME COSNTTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE CON MEJORÍA DE DOLOR TORACICO, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGÍA NUEVA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

06/03/2022

AST 147, ALT 108, CLORO 103, POTASIO 3.8, SODIO 134, LEUC 6.16, NEUT 3.91, HB 9.3, VCM 81.7, PLT 301

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXAMEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE, RESULTADO DE HEPATITIS B NEGATIVO. VDRL NEGATIVO. TIENE PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA MAS LAVADO BRONQUIALVEOLAR GENEXPERT SOLICITADO DESDE EL 02/03/22, CARGA VIRAL. CONTINUAMOS ESPERANDO VALORACION POR TRABAJO SOCIAL. IONOGRAMA Y HEMOGRAMA SIN ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS. EN EL MOMENTO PACIENTE CON EVIDENTE MEJORIA CLINICA EN CUANTO A FECHA DE INGRESO. SE LE INFORMA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 08/03/2022: 09:45:23, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME COSNTTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. SINTOMATICO RESPIRATORIO A CARACTERIZAR: 4.1 TUBERCULOSIS PULMONAR A CONFIRMAR 4.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE CALIENTE, NIEGA DOLOR ABDOMINAL, NIEGA VOMITOS, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGÍA NUEVA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SE PALPA GNAGLIO AXILAR DERECHO INFLAMADO, MOVIBLE. MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15. ULTIMOS RESULTADOS DE LABORATORIOS: 06/03/2022 AST 147, ALT 108, CLORO 103, POTASIO 3.8, SODIO 134, LEUC 6.16, NEUT 3.91, HB 9.3, VCM 81.7, PLT 301

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE LA TERCERA DECADA DE LA VIDA, SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS REFERIDOS. EN CONTEXTO DE HIV DE NOVO + SINTOMATICA RESPIRATORIA A CARACTERIZAR. ACTUALMENTE AL EXAMEN FISICO PACIENTE ADELGAZADA, CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, AFEBRIL, EUCARDICA, EUPENICA, TOLERANDO VIA ORAL Y TOLERANDO OXIGENO AMBIENTE, PRESENTA HALLAZGOS DE GANGLIOS SUPRACLAVIculares, AXILAR DERECHO E INGUINALES PALPABLES, NO DOLOROSOS. EN EL MOMENTO PACIENTE CUENTA CON MANEJO CON TERAPIA RIPE, RESULTADO DE HEPATITIS B NEGATIVO. VDRL NEGATIVO. TIENE PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA MAS LAVADO BRONQUIALVEOLAR GENEXPERT SOLICITADO DESDE EL 02/03/22. CONTINUAMOS ESPERANDO VALORACION POR TRABAJO SOCIAL. SE SOLICITA HLG, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, BT, BD, FA, AST, ALT, FA, PCR, HEMOCULTIVO N2, UROCULTIVO Y RAYOS X DE TORAX DE CONTROL. CONTINUA CON TERAPIA RIPE Y ANTIRRETROVIRALES. SE LE INFORMA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 09/03/2022: 12:11:28, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

2. SINDROME COSNTTITUCIONAL

3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

4. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO

Subjetivo:

PACIENTE RELATA SENTIRSE BIEN, NIEGA NAUSEAS, NO VOMITO, NIEGA FIEBRE, NIEGA OTROS SINTOMAS.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 97 LPM, FR: 17 RPM, SATO2: 98%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

SE TRATA DE UNA PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE VIH ESTADIO C2, HOSPITALIZADA POR OPACIDADES PULMONARES EN AMBOS PULMONARES EN PATRÓN MLIAR. ACTUALMENTE PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, AFEBRIL; POR ELEVACIÓN DE TRANSAMINASAS Y CUADRO FEBRIL REFRACTARIO ASOCIADO A SIRS SE CONSIDERO PROCESO SEPTICO CONCOMITANTE; SE DIFIRIO TERAPIA RIPE Y SE INICIO ANTIBIOTICOTERAPIA DE AMPLIO ESPECTRO. ME ENCUENTRO EN ESPERA DE REPORTE DE HEMOCULTIVOS PARA DIRIGIR ANTIBIOTICO. EXPLICO A PACIENTE DIAGNOSTICO, EVOLUCIÓN Y PLAN A SEGUIR, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 09/03/2022: 17:23:41, Historia: Notas, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Asunto: NOTAMEDICA

Descripción: PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS: 1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME CONSTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO PACIENTE CON ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICOS PREVIAMENTE DESCRITOS, A QUIEN EL DIA DE MAÑANA SE LE REALIZARA NASOFIBROBRONCOSCOPIA + LAVADO BRONCOALVEOLAR, POR LO CUAL SE LE ORDENO REALIZAR ANTIGENO PARA SARS COV2. SE ORDENAN ADEMAS PARACLINICOS CONTROL, SE INFORMA PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 10/03/2022: 12:13:11, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS: 1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME CONSTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO MALA NOCHE, DOLOR TORACICO, FIEBRE, LUMBALGIA, DISNEA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 97 LPM, FR: 17 RPM, SATO2: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE VIH ESTADIO C2, HOSPITALIZADA POR OPACIDADES PULMONARES EN AMBOS PULMONARES EN PATRÓN MLIAR. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, AFEBRIL; POR ELEVACIÓN DE TRANSAMINASAS Y CUADRO FEBRIL REFRACTARIO ASOCIADO A SIRS SE CONSIDERO PROCESO SEPTICO CONCOMITANTE; SE DIFIRIO TERAPIA RIPE Y SE INICIO ANTIBIOTICOTERAPIA DE AMPLIO ESPECTRO. SE AÑADE TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL A CUBRIMIENTO ANTIBIOTICO POR SOSPECHA DIAGNOSTICA. CONTINUAMOS A LA ESPERA EN ESPERA DE REPORTE DE HEMOCULTIVOS. SE EXPLICA A PACIENTE DIAGNOSTICO, EVOLUCIÓN Y PLAN A SEGUIR, REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR ATENTOS Y EVOLUCION.

Fecha: 11/03/2022: 12:19:15, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS: 1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME CONSTITUCIONAL 3. SINDROME ANEMICO SEVERO MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 4. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PERSISTENCIA DE LA FIEBRE MODULACION DEL DOLOR

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 28 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCUENTRA EN OBSERVACION CON DIAGNOSTICOS Y ANTECEDENTES ANOTADOS EN EL MOMENTO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES AFEBRIL HIDRATADA CON BUEN PATRON RESPIRATORIO TAQUICARDICA PRESION ARTERIAL MEDIA CONSERVADA AL EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI POR LO QUE SE SOLICITA VALORACION POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y SE INDICA MANEJO CON TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL, SE SOLICITAN ADEMAS GASES ARTERIALES. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA Y REPORTES PARA DEFINIR CONDUCTA, SE EXPLICA A LA PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 12/03/2022: 11:17:25, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO

3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL

4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA, POR MOMENTOS PICOS FEBRILES. NO DISNEA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

11/03/22

GAES ARTERIALES PH 7.49, PCO2 29.3, HCO3 22.1 PAFI 522 LACT 2.86

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 28 AÑOS DE EDAD QUIEN SE BAJO VIGILANCIA Estricta POR COMPLICACIONES ASOCIADAS A PATOLOGIAS DE BASE. CON DIAGNOSTICOS Y ANTECEDENTES ANOTADOS EN EL MOMENTO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES. HIDRATADA CON BUEN PATRON RESPIRATORIO TAQUICARDICA PRESION ARTERIAL MEDIA CONSERVADA AL EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES TENIENDO EN CUENTA LOA NTERIOR NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI POR LO QUE SE SOLICITA VALORACION POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y SE INDICA MANEJO CON TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL. SE CONTINUA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO ESTABLECIDO EL DIA DE AYER 11-03-22 HOY EN SU SEGUNDO DIA ATENTOS A EVOLUCION CLINICA SE LE EXPLICA CONEXO Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIENN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 13/03/2022: 10:05:04, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA PICOS FEBRILES, REFIERE SENTIRSE BIEN.

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

12/03/2022: HEMOGRAMA: LEU 3.790 NEU 2.100 LINFO 930 MONO 290 EOSI 270 BASI 40 HB 8.1 HTO 27.8 VCM 83.2 HCM 24.4 CCMH 29.3 PLT 296.000 PDW 36.9

BUN 14 FA 196 NA 132 CL 100 K 3.9 BILI TOTAL 0.43 DIRECTA 0.1 CR 0.73 PCR 8.6 AST 42 ALT 59

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD QUIEN SE BAJO VIGILANCIA Estricta POR COMPLICACIONES ASOCIADAS A PATOLOGIAS DE BASE. CON DIAGNOSTICOS Y ANTECEDENTES ANOTADOS EN EL MOMENTO PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES. HIDRATADA CON BUEN PATRON RESPIRATORIO TAQUICARDICA PRESION ARTERIAL MEDIA CONSERVADA AL EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES TENIENDO EN CUENTA LOA NTERIOR NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI. PENDIENTE VALORACION POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA EN MANEJO CON TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL DESDE EL DIA 11-03-22, HOY EN SU TERCER DIA. SE CONTINUA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO ESTABLECIDO ATENTOS A EVOLUCION CLINICA SE LE EXPLICA CONEXO Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIENN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 14/03/2022: 12:34:42, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DIAGNOSTICOS:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE RELATA SENTIRSE BIEN, NIEGA DISNEA, NIEGA NAUSEAS, NO VOMITO, NIEGA OTROS SINTOMAS.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA 110/60 MMHG, FC: 97 LPM, FR: 17 RPM, SAT O2: 98%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMAS RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE REGULARES CONDICIONES GENERALES POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES. HIDRATADA CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES TENIENDO EN CUENTA LOA ANTERIOR NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI. PENDIENTE VALORACION POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA CONTINUA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO ESTABLECIDO ATENTOS A EVOLUCION CLINICA SE LE EXPLICA CONEXO Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIENN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 15/03/2022: 12:00:50, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA NO TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE REGULARES CONDICIONES GENERALES POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES. HIDRATADA CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI. PENDIENTE VALORACION POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA CONTINUA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO ESTABLECIDO ATENTOS A EVOLUCION CLINICA. SE LE EXPLICA CONEXO Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 16/03/2022: 11:28:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA.

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE REGULARES CONDICIONES GENERALES POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES. HIDRATADA CON BUEN PATRON RESPIRATORIO EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI. PENDIENTE VALORACION POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y PARACLINICOS, CONTINUA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO ESTABLECIDO ATENTOS A EVOLUCION CLINICA. SE LE EXPLICA CONEXO Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 17/03/2022: 17:18:35, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO
- 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL
4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 110/60 MMHG, FC: 80 LPM, FR: 17 RPM, SAT02: 95%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. AL EXAMEN FISICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO, CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, POR LO CUAL NO SE DESCARTA INFECCION POR NEUMOCISTIS JIROVECCI. ES VALORADA POR SERVICIO DE NEUMOLOGIA QUIENES SOLICITAN FIBROBRONCOSCOPIA MÁS BIOPSIA TRANSBRONQUIAL. SE SOLICITA HEMOGRAMA, PERFIL HEPÁTICO, FUNCIÓN RENAL E IONOGRAMA CONTROL. CONTINUA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO ESTABLECIDO. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 18/03/2022: 10:13:29, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

P:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME ANEMICO GRAVE MICROCITICO E HIPOCROMICO CON REQUERIMIENTO DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS 22/02/2022
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO
- 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL
4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

S:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA.

Objetivo:

O:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 110 LPM, FR: 18 RPM, SAT02: 97%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15.

PARACLINICOS

17.03.22 CR 0.70 BUN 19 K 3.7 ALT 67 CL 94 AST 71 NA 129 LEU 4.35 NEU 57.9 LINFO 1.07 HB 9.4 HTO 31.5 VCM 85.1 HCM 25.4 CCMH 29.8 PLAQ 285

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Análisis:

A:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. AL EXAMEN FÍSICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO, CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, POR LO CUAL NO SE DESCARTA INFECCIÓN POR NEUMOCISTIS JIROVECCI. ES VALORADA POR SERVICIO DE NEUMOLOGÍA QUIENES SOLICITAN FIBROBRONCOSCOPIA MÁS BIOPSIA TRANSBRONQUIAL QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE. CUENTA CON PARACLÍNICOS DEL DÍA DE HOY QUE REPORTAN FUNCIÓN RENAL CONSERVADA TRANSAMINASAS LIGERAMENTE ELEVADAS SIN EMBARGO NO SUPERA NIVELES DE SUSPENSIÓN IONOGRAMA CON HIPONATREMIA LEVE HEMOGRAMA CON LEUCOPENIA ANEMIA MODERADA RESTO DE LINEAS CELULARES DENTRO DE LA NORMALIDAD ANTE LO ANTERIOR SE REINICIA MANEJO CON TERAPIA RIPE RIFAMPICINA, ISONIACIDA, PIRACINAMIDA, ETAMBUTOL SE. CONTINÚA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO CON MODIFICACIONES. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 19/03/2022: 13:07:01, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 3.1 SÍNDROME CONSTITUCIONAL
4. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO TIPO:
- 4.1 HIPONATREMIA MODERADA
- 4.2 HIPOCLOREMA LEVE
5. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MÓVILES. TORAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. AL EXAMEN FÍSICO CON MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO, CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, DE MOMENTO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE BIOPSIA TRANSBRONQUIAL DE MOMENTO CONTINÚA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO CON ORDENES MÉDICAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y SE SOLICITAN EXÁMENES DE CONTROL. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 20/03/2022: 13:21:52, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 3.1 SÍNDROME CONSTITUCIONAL
4. TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO TIPO:
- 4.1 HIPONATREMIA MODERADA
- 4.2 HIPOCLOREMA LEVE
5. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MÓVILES. TORAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

PARACLÍNICOS

19/03/22: CR 0.70 BUN 21 CL 99 NA 133 K 4.4

HEMOGRAMA: LEU 5.500 NEU 3.550 LINFO 1.180 MONO 290 EOSI 70 HB 9.0 HTO 29.1 VCM 84.4 HCM 26.0 CCMH IDE 21.8 PLT 281.000 VPM 10.4 PTC 0.29 PDW 37.4

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. SE RECIBEN PARACLÍNICOS EL DÍA DE LOS CUALES REPORTAN HEMOGRAMA SIN ALTERACIONES AZOADAS SIN ALTERACIONES E IONOGRAMA NORMAL, HOY AL DÍA 11 DE INICIO DE TERAPIA RIPE LA CUAL SE HA SUSPENDIDO EN VARIAS OCASIONES DEBIDO A ELEVACIÓN DE TRANSAMINASA POR LO CUAL EL DÍA DE HOY SOLICITAMOS TRANSAMINASAS CONTROL JUNTO HEMOGRAMA CONTROL, FUNCIÓN RENAL IONOGRAMA Y GLUCOSA CENTRAL, A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE BIOPSIA TRANSBRONQUIAL DE MOMENTO CONTINÚA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO CON ORDENES MÉDICAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 21/03/2022: 12:46:55, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- 3.1 SÍNDROME CONSTITUCIONAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO:

4.1 HIPONATREMIA MODERADA

4.2 HIPOCLOREMA LEVE

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOML, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAMULARES INFLAMADOS, MOVILES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

PARACLINICOS

20/03/22:

LEU 3.13 NEU 47.8% LINF 24.1% HB 9 HTO 30.1 VCM 85.5 HCM 25.6 PLAQ 290 AST 93 ALT 89 GLUC 114 NA 131 K 3.9 CL 97 BUN 17 CREAT 0.72

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. SE RECIBEN PARA CLINICOS EL DIA DE LOS CUALES REPORTAN LEUCOPENIA ASOCIADO CON LEVE MEJORIA EN LAS ENZIMAS HEPATICAS, HOY AL DIA 12 DE INICIO DE TERAPIA RIPE LA CUAL SE HA SUSPENDIDO EN VARIAS OCASIONES DEBIDO A ELEVACIÓN DE TRANSAMINASA A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE BIOPSIA TRANSBRONQUIAL DE MOMENTO CONTINÚA CON TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO CON ÓRDENES MÉDICAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 22/03/2022: 13:26:04, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

2. SINDROME ANEMICO MODERADA

3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO

3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL

4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO:

4.1 HIPONATREMIA MODERADA

4.2 HIPOCLOREMA LEVE

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOML, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAMULARES INFLAMADOS, MOVILES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

PARACLINICOS:

22/03/22:

BIOPSIA TRANSBRONQUIAL:

MACROSCOPICA: ROTULADO LAVADO BRONQUIAL. SE RECIBE 10 CC DE LIQUIDO PARDO ROJIZO, SE PROCESA POR TECNICA DE CITOSPYN Y SE OBTIENE EXTENDID. SE COLOREA Y ROTULA PARA LA LECTURA

MICROSCOPICA

EL EXTENDIDO MUESTRA SOLO UN FONDO PROTEINACEO, CON CELULAS INFLAMATORIAS MIXTAS, NO SE RECONOCEN CELULAS EPITELIALES NI MACROFAGOS ALVEOLARES

DIAGNOSTICO

CITOLOGIA DE LAVADO BRONQUIAL:

NO DIAGNOSTICO, SIN REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS EPITELIALES

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. EL DIA DE HOY SE DECIDE SUSPENDER TERAPIA RIPE ANTE ELEVACIONES PERSISTENTES DE ENZIMAS HEPATICAS DE PARALCLINICOS CONTROL, Y SE CONTEMPLA INICIAR TERAPIA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TUBERCULOSIS, EL DIA DE HOY SE SOLICITAN HEMOGRAMA CONTROL AZOADOS, IONOGRAMA PERIL HEPATICO Y LDH CONTROL, SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 23/03/2022: 11:48:03, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

2. SINDROME ANEMICO MODERADA

3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO

3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL

4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO:

4.1 HIPONATREMIA MODERADA

4.2 HIPOCLOREMA LEVE

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

TA 110/980 FC 110 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOML, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAMULARES INFLAMADOS, MOVILES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

PARACLINICOS:

22/03/2022 PCR 4.8, BT 1.19, BD 0.1, LDH 250,

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. PENDIENTE INICIAR TERAPIA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TUBERCULOSIS DEBIDO A ELEVACIONES DE ENZIMAS HEPATICAS PRESENTADA CON TERAPIA RIPE, SE RECIBEN PARA CLINICOS DEL DIA DE HOY LOS CUALES REPORTAN PARAMETROS DENTRO DE LA NORMALIDAD, SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 24/03/2022: 14:50:33, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA 4.2 HIPOCLOREMA LEVE 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

TA 110/80 FC 110 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. PENDIENTE INICIAR TERAPIA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TUBERCULOSIS DEBIDO A ELEVACIONES DE ENZIMAS HEPATICAS PRESENTADA CON TERAPIA RIPE. SE SOLICITAN PARA CLINICOS DE CONTROL EMOGRAMA, IONOGRAMA, AST, ALT, FUNCIÓN RENAL. SE SOLICITA FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 25/03/2022: 13:22:21, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME ANEMICO MODERADA
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO
3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL
4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO:
4.1 HIPONATREMIA MODERADA
4.2 HIPOCLOREMA LEVE
5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

TA 110/80 FC 110 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15

PARACLINICOS

24/03/22:

- HEMOGRAMA: LEU 3.91 NEU 1.97 HB 9.5 HTO 32.1 VCM 85.7 HCM 25.4 CCMG 29.6 IDE 21.4 PLAQ 331

- AST 77 ALT 93 NA 135 CL 101 K 4.2 CR 0.59 BUN 18

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO, SE RECIBEN PARA CLINICOS EL DIA DE HOY LOS CUALES REPORTAN HEMOGRAMA DENTRO DE PARAMETROS NORMALES, ENZIMAS HEPATICAS EN DESCENSO E IONOGRAMA CON TRASTORNOS ASOCIADOS A HIPONATREMIA MODERADA E HIPOCLOREMA LEVE, EL DIA DE HOY SE ORDENA CONTROL DE PERFIL HEPATICO PARA SEGUIR TITULANDO DESCENSO DE ENZIMAS HEPATICAS A NIVELES OPTIMOS Y PODER INICIAR TERAPIA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TUBERCULOSIS, PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 26/03/2022: 09:59:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME ANEMICO MODERADA
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO
3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL
4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO:
4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA
4.2 HIPOCLOREMA LEVE RESUELTO
5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

TA 110/80 FC 110 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA. SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. PARA CLINICOS: 15/15 - 25/03/22:

AST 76 ALT 88 BT 0.94 BD 0.1

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO, SE RECIBEN PARA CLINICOS EL DIA DE HOY LOS CUALES REPORTAN ENZIMAS HEPATICAS EN DESCENSO. EL DIA DE HOY SE ORDENA CONTROL DE HEMOGRAMA, FUNCION RENAL, IONOGRAMA, PERFIL HEPATICO PARA SEGUIR TITULANDO DESCENSO DE ENZIMAS HEPATICAS A NIVELES OPTIMAS Y PODER INICIAR TERPIA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TUBERCULOSIS, PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 27/03/2022: 10:51:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE SENTIRSE MEJOR, HABER PASADO BUENA NOCHE. NO DISNEA. NO TAQUIPNEA

Objetivo:

TA 120/80 FC 110 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA. SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15/15. PARA CLINICOS: 26/03/22: CL:100 BD:0.4 BT:0.66 AST:74 ALT:87 BUN:17 CR:0.88 FOSFATASA ALCALINA:278 K:3.9 NA:134 HB:9.9 HTO:32.7 VCM:86.5 HCM:25.5 LEU:3.62 NEU:2.07 LIN:0.90 MON:0.30 EOS:0.19 BAS:0.03 PLAQ:344

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO, SE RECIBEN PARA CLINICOS EL DIA DE HOY LOS CUALES REPORTAN ANEMIA MODERADA, LEUCOPENIA Y NEUTROPENIA. PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 28/03/2022: 12:39:20, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)
2. SINDROME ANEMICO MODERADA
3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO
3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL
4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO:
4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA
4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA
5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

TA 100/60 FC 90 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIculares INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA. SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. 26/03/22: CL:100 BD:0.4 BT:0.66 AST:74 ALT:87 BUN:17 CR:0.88 FOSFATASA ALCALINA:278 K:3.9 NA:134 HB:9.9 HTO:32.7 VCM:86.5 HCM:25.5 LEU:3.62 NEU:2.07 LIN:0.90 MON:0.30 EOS:0.19 BAS:0.03 PLAQ:344

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. SE RECIBEN PARA CLINICOS DE CONTROL QUE REPORTAN ANEMIA MODERADA, ENZIMAS HEPATICAS CON LEVES DESCENSOS. ATENTOS A VARIACIONES EN PERFIL HEPATICO PARA SEGUIR TITULANDO DESCENSO DE ENZIMAS HEPATICAS A NIVELES OPTIMAS Y PODER INICIAR TERPIA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TUBERCULOSIS, PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 28/03/2022: 12:47:25, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

TA 110/70 FC 97 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. SE SOLICITAN PARA CLÍNICOS DE CONTROL HEMOGRAMA, FUNCIÓN RENAL, TRANSAMINASAS PARA SEGUIR TITULANDO DESCENSO DE ENZIMAS HEPATICAS A NIVELES OPTIMOS. SE DECIDE ESCALONAR TERAPIA RIPE INICIANDO MANEJO CON ETAMBUTOL, FÁRMACO MENOS HEPATOTÓXICO. PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 29/03/2022: 11:08:39, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

TA 110/60 FC 87 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. PARA CLÍNICOS: 28/03/22:

LEU: 3.920 HB: 9.5 HTO: 31.6 VCM: 85 HCM: 25.4 IDE: 20.6 PLA: 348.000 AST: 92 ALT: 96 BUN: 6 CREAT: 0.73

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. SE RECIBEN PARA CLÍNICOS DE CONTROL LOS CUALES REPORTAN ANEMIA MODERADA, LEUCOPENIA Y FUNCIÓN RENAL CONSERVADA. SE DECIDE ESCALONAR TERAPIA RIPE INICIANDO MANEJO CON ETAMBUTOL, FÁRMACO MENOS HEPATOTÓXICO. PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 30/03/2022: 10:27:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

TA 110/60 FC 87 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. PARA CLÍNICOS: 29/03/2022 TP: 11.0, TTP: 28.1, CR: 0.60, BUN: 16, LEU: 3.89, NEUT: 53.4, LINF: 28.0, MON: 9.7, EOS: 4.4, BAS: 0.4, ERT: 3.55, HTO: 30.3, HB: 9.1, VCM: 85.5, HCM: 25.8, CCMH: 30.1, IDE: 20.5, PLQ: 343, VPM: 11.2

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. SE RECIBEN PARA CLÍNICOS DE CONTROL LOS CUALES REPORTAN ANEMIA MODERADA, LEUCOPENIA Y FUNCIÓN RENAL CONSERVADA. SE DECIDE ESCALONAR TERAPIA RIPE INICIANDO MANEJO CON ETAMBUTOL, EL CUAL CONTINUA PENDIENTE EN SU INICIACION DEBIDO A QUE FARMACIA NO TIENE DISPONIBILIDAD DE ESTE, PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 30/03/2022: 12:52:09, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: WILHEN ARIZA ESCOBAR, Especialidad: NEUMOLOGIA

Problema:

SDI

Subjetivo:

SDI

Objetivo:

SDI

Análisis:

PACIENTE TIEN UN PRUEBA MOLECULAR DX PARA M. TUBERCULOSI GENEXPERT MTB/RIF DEL 30/03/22 CON SENSIBILIDAD A RIFAMPICINA E ISONIAZIDA, POR LO TANTO NO REQUIERE DE NUEVA FIBROBRONCOSCOPIA. SE SUSPENDER POR LO TANTO EL PROCEDIMIENTO.

Fecha: 31/03/2022: 16:44:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

REFIERE BUENA NOCHE

Objetivo:

TA 110/60 FC 87 TEMP 36 GRADOS FR 20 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. PARACLINICOS: 29/03/2022 TP: 11.0, TTP: 28.1, CR: 0.60, BUN: 16, LEU: 3.89, NEUT: 53.4, LINF: 28.0, MON: 9.7, EOS: 4.4, BAS: 0.4, ERT: 3.55, HTO: 30.3, HB: 9.1, VCM: 85.5, HCM: 25.8, CCMH: 30.1, IDE: 20.5, PLQ: 343, VPM: 11.2

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADA A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS CON PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. EL DIA DE HOY SE SOLICITAN PARACLINICOS DE CONTROL. SE DECIDE ESCALONAR TERAIA RIPE INICIANDO MANEJO CON ETAMBUTOL, EL CUAL CONTINUA PENDIENTE EN SU INICIACION DEBIDO A QUE FARMACIA NO TIENE DISPONIBILIDAD DE ESTE, PENDIENTE FIBROBRONCOSCOPIA + BIOPSIA. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 01/04/2022: 11:58:14, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

TA 120/60 FC 88 TEMP 36,3 GRADOS FR 20 SATO2 97%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. PARACLINICOS: 29/03/2022 TP: 11.0, TTP: 28.1, CR: 0.60, BUN: 16, LEU: 3.89, NEUT: 53.4, LINF: 28.0, MON: 9.7, EOS: 4.4, BAS: 0.4, ERT: 3.55, HTO: 30.3, HB: 9.1, VCM: 85.5, HCM: 25.8, CCMH: 30.1, IDE: 20.5, PLQ: 343, VPM: 11.2

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADA A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. EL DIA DE HOY SE SOLICITAN PARACLINICOS DE CONTROL. SE DECIDE ESCALONAR TERAPIA RIPE INICIANDO MANEJO CON ETAMBUTOL FI 31.03.2022. SE SOLICITA AST, ALT, BILIRRUBINAS. SEGUIMOS ATENTOS A SU EVOLUCIÓN CLÍNICA SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 02/04/2022: 13:09:17, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO 3.1 SINDROME CONSTITUCIONAL 4. TRASTORNO HIDROELECTROLITICO TIPO: 4.1 HIPONATREMIA MODERADA RESUELTA 4.2 HIPOCLOREMIA LEVE RESUELTA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

TA 115/65 FC 88 TEMP 36,3 GRADOS FR 18 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMETRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA EN LA TERCERA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA ASOCIADA A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRON RESPIRATORIO. EL DIA DE HOY SE SOLICITAN PARACLINICOS DE CONTROL. SE DECIDE ESCALONAR TERAPIA RIPE INICIANDO MANEJO CON ETAMBUTOL FI 31.03.2022. SE SOLICITA AST, ALT, BILIRRUBINAS REPORTADAS EL DIA DE HOY DENTRO DE PARAMETROS NORMALES, POR LO CUAL CONTINUAMOS IGUAL ESQUEMA EN SEGUIMIENTO ESTRICTO DE FUNCION HEPATICA. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 03/04/2022: 12:00:32, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINO DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO

2. SINDROME ANEMICO MODERADA

3. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

TA 115/65 FC 88 TEMP 36,3 GRADOS FR 18 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HUMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MOVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVIARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TORAX EXPANSIBLE SIMETRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CREPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACION PROFUNDA GENERALIZADA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW.
Análisis:
PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. EL DÍA DE HOY SE SOLICITAN PARA CLÍNICOS DE CONTROL. EN MANEJO CON TERAPIA RIPE ESCALONADA CON ETAMBUTOL FI 31.03.2022. PARA CLÍNICOS AST, ALT, BILIRRUBINAS REPORTADAS EL DÍA DE HOY DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES, POR LO CUAL CONTINUAMOS IGUAL ESQUEMA EN SEGUIMIENTO Estricto de función hepática. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 04/04/2022: 12:55:42, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINO DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A: 1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO 2. SINDROME ANEMICO MODERADA 3. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FIEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA: 110/70 MMHG FC: 88 LPM TEMP: 36,3° FR: 18 RPM SATO2: 97%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW 15.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, CON INJURIA HEPATICA POR TERAPIA ANTITUBERCULOSA QUE OBLIGO A LA SUSPENSIÓN Y SE ENCUENTRA EN PROTOCOLO DE REINTRODUCCIÓN DE LA TERAPIA CON SEGUIMIENTO A LAS AMINOTRANSFERASAS. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. EL DÍA DE HOY SE SOLICITAN PARA CLÍNICOS DE CONTROL PARA TOMAR MAÑANA EN LA MADRUGADA. POR LO CUAL CONTINUAMOS IGUAL ESQUEMA EN SEGUIMIENTO Estricto de función hepática. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 05/04/2022: 12:02:21, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINO DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO

2. SINDROME ANEMICO MODERADA

3. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FIEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA 125/75 FC 88 TEMP 36,3 GRADOS FR 18 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. EL DÍA DE HOY SE SOLICITAN PARA CLÍNICOS DE CONTROL. EN MANEJO CON TERAPIA RIPE ESCALONADA CON ETAMBUTOL FI 31.03.2022. Y PIRAZINAMIDA FI 05/04/2022. POR LO CUAL CONTINUAMOS IGUAL ESQUEMA EN SEGUIMIENTO Estricto de función hepática POR LO QUE SE SOLICITA HEMOGRAMA, PCR, IONOGRAMA, BUN, CREATININA, AST, ALT, LDH, BT, BD. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.

Fecha: 06/04/2022: 10:05:19, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SINDROME ANEMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere que pasa la noche tranquila.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición decúbito supino, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria

SIGNOS VITALES

FC 90 PA: 100/60 mmHg SATO2: 98%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES

CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVILES.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS
 ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES.

Análisis:

Paciente de 29 años con diagnóstico de VIH (2016) en manejo con TARV. Actualmente en contexto de tuberculosis pulmonar, en manejo con tetraconjugado iniciado de forma escalonada por historia de toxicidad hepática asociado a tratamiento, actualmente en manejo con etambutol con adecuada respuesta clínica y paraclínica, con aminotransferasas estables, se indicó inicio de pirazinamida la cual empezará el día de hoy. Actualmente estable, con paraclínicos de control dentro de parámetros aceptables, con hiponatremia crónica no sintomática. Por el momento no se realiza otras modificaciones en su tratamiento. Se explica paciente conducta médica a seguir, se solucionan dudas, refiere comprender

Fecha: 07/04/2022: 10:43:58, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS:

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANÉMICO MODERADA

5. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en aceptables condiciones generales, pasa la noche tranquila, no otra sintomatología

Objetivo:

SIGNOS VITALES

FC 80 lpm PA: 100/60 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES.

PARACLÍNICOS

07/04/2022 BT 0.4 BD 0.1 AST 68 ALT 73

Análisis:

Paciente de 29 años con diagnóstico de VIH (2016) en manejo con TARV. Actualmente en contexto de tuberculosis pulmonar, en manejo con tetraconjugado iniciado de forma escalonada por historia de toxicidad hepática asociado a tratamiento, actualmente en manejo con etambutol con adecuada respuesta clínica y paraclínica, con aminotransferasas estables, se indicó inicio de pirazinamida la cual no ha empezado, el día de hoy nos comunicamos nuevamente con farmacia y entidad gestora de entrega de medicamentos, en trámites para su consecución y entrega. Por el momento la paciente permanece estable Continuaremos atentos a evolución clínica de paciente. Se explica paciente conducta médica a seguir, se solucionan dudas, refiere comprender

Fecha: 08/04/2022: 10:21:08, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANÉMICO MODERADA

5. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente en cama, luce tranquila, pasa la noche sin novedad.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en habitación de aislamiento, luce tranquila.

SIGNOS VITALES

FC: 88 lpm PA: 120/80 mmHg SATO2 97%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES.

10/03/2022 LBA GENEXPERT

Rifampicina: Sensible

Isoniazida: Sensible

Análisis:

Paciente de 29 años con diagnóstico de VIH (2016) en manejo con TARV. Actualmente en contexto de tuberculosis pulmonar, en quien se inició terapia RIE de forma escalonada por historia de toxicidad hepática asociado a tratamiento, actualmente en manejo con etambutol con adecuada respuesta clínica y paraclínica, con aminotransferasas estables, el día de ayer 07/04/2022 inició pirazinamida, hasta el momento con adecuada evolución y tolerancia clínica. Por el momento la paciente permanece estable Continuaremos atentos a evolución clínica de paciente. Se explica paciente conducta médica a seguir, se solucionan dudas, refiere comprender.

Fecha: 09/04/2022: 11:00:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANÉMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Refiere sentirse en buenas condiciones generales. Niega alzas térmicas, niega otra sintomatología.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, sin acompañante, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria

SIGNOS VITALES

FC 83 PA: 100/70 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GLANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MÓVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GLANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES.

Análisis:

Paciente de 29 años con diagnóstico de VIH (2016) en manejo con TARV. Actualmente en contexto de tuberculosis pulmonar, en quien se inició terapia RIE de forma escalonada por historia de toxicidad hepática asociado a tratamiento, actualmente en manejo con etambutol con adecuada respuesta clínica y paraclínica, con aminotransferasas estables, se encuentra en manejo con etambutol+pirazinamida con adecuada tolerancia, el día de mañana se realizará control paraclínico. Se explica a paciente conducta médica a seguir.

Fecha: 10/04/2022: 10:59:08, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS 1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A: 1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO 3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS 4. SÍNDROME ANÉMICO MODERADA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE MEJOR, MEJORA DE LA TOS SIN FIEBRE

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GLANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MÓVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GLANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES.

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH (2016) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, ACTUALMENTE EN MANEJO CON ETAMBTOL CON ADECUADA RESPUESTA CLÍNICA Y PARACLÍNICA, CON AMINOTRANSFERASAS ESTABLES, SE ENCUENTRA EN MANEJO CON ETAMBTOL+PIRAZINAMIDA CON ADECUADA TOLERANCIA, CON CONTROL DE TRANSAMINASAS ESTABLE. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR.

Fecha: 11/04/2022: 11:51:16, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE FEMENINO DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO

2. SÍNDROME ANÉMICO MODERADA

3. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FIEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA 115/65 FC 88 TEMP 36,3 GRADOS FR 18 SATO2 97% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GLANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MÓVILES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GLANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW.

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. EL DÍA DE HOY SE SOLICITAN PARACLÍNICOS DE CONTROL. EN MANEJO CON TERAPIA RIPE ESCALONADA CON ETAMBTOL FI 31.03.2022. Y PIRAZINAMIDA FI 05/04/2022. POR LO CUAL CONTINUAMOS IGUAL ESQUEMA EN SEGUIMIENTO Estricto de función hepática por lo que se solicita hemograma, PCR, IONOGRAMA, BUN, CREATININA, AST, ALT, LDH, BT, BD. SE SOLICITA TACX DE CUELLO, TÓRAX Y ABDOMEN CON EL FIN DE IDENTIFICAR PLORIFICACIÓN DE ENFERMEDAD POR MÚLTIPLES GLANGLIOS EN ZONA RETROAURICULAR, DEL CUELLO Y SUPRACLAVICULAR. SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 12/04/2022: 10:38:30, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

DIAGNÓSTICOS

1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en buenas condiciones generales, paso la noche tranquila, menciona ligero dolor en región cervical izquierdo. Niega alzas térmicas, niega otra sintomatología.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, luce tranquila.

SIGNOS VITALES

FC 86 lpm PA: 100/60 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: Mucosas húmedas y rosadas

CUELLO: Adenopatías palpables supraclaviculares, y a lo largo del esternocleidomastoideo bilateral, predominio izquierdo, además con adenopatía preauricular prominente, dolorosa izquierda.

ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias palpables

EXTREMIIDADES: Símétricas.

PARACLÍNICOS

11/04/22: CREAT:1.05 K:4.3 ALT:65 AST:54 BUN:25 NA:134 LEU:4300 HB:10.9 HTO:36.6 VCM:86.5 HCM:25.7 IDE:18.6 PLAQ:256.000

Análisis:

Paciente de 29 años con diagnóstico de VIH (2016) en manejo con TARV. Actualmente en contexto de tuberculosis pulmonar, en quien se inició terapia RIE de forma escalonada por historia de toxicidad hepática asociado a tratamiento, actualmente en manejo con etambutol + pirazinamida, el día de ayer se adicionó manejo con rifampicina la cual iniciará el día de hoy. En el momento con parámetros que evidencian aintotransferasas estables, sin otros hallazgos. Tiene pendiente reevaluación de TAC de cuello, tórax y abdomen por presencia de cadenas ganglionares prominentes cervicales y supraclaviculares predominio izquierdo. Se explica a paciente conducta médica a tomar, se solucionan dudas, se refiere a comprender.

Fecha: 13/04/2022: 09:51:59, Historia: Notas, Prestador: DANIEL VARGAS, Especialidad: ANESTESIOLOGIA

Asunto: NOTA ANESTESIOLOGIA DR DANIEL VARGAS

Descripción: NOTA COMPLEMENTARIA/MEDICACION RECIBIDA POR EL PACIENTE: - ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HORAS - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DIA - TERAPIA RIPE RIFAMPICINA/ISONIACIDA/PIRACINAMIDA/ETAMBUTOL 150/75/400/275 MG 3 TAB VO CADA DIA (FI: 27/02/22): D9/56***DIFERIDO 08/03/22, REINICIADO 18/03/22*** D11/56***SUSPENDIDO 22/03/22*** - ETAMBUTOL TAB 275 MG ADMINISTRAR 2 TABLETAS DIA (FI: 31/03/22) - PIRAZINAMIDA TAB 400 MG ADMINISTRAR 2 TABLETAS AL DIA (FI:07/04/2022) - RIFAMPICINA TAB 300 MG TOMAR 2 TAB VO DIA (FI:11/04/22) - PIRIDOXINA 50 MG VO CADA DIA - ABACAVIR SULFATO Y LAMIVUDINA TAB 600MG/300MG, 1 TAB DIA - TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160/800 MG 1 TABLETA VO CADA 12 HORAS (FI 18/03/22) - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA 24 HORAS - SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA -ORDENES: AISLAMIENTO POR GOTAS - MASCARILLA N95 PERMANENTESUSPENDER ENOXAPARINA 12 HORAS ANTES DE LA CIRUGIA

Fecha: 13/04/2022: 12:01:42, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS:

1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en buenas condiciones generales.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, posición decúbito supino, sin acompañante, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria.

SIGNOS VITALES

FC: 80 lpm PA: 100/60 mmHg SATO2: 96%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA: Mucosas húmedas y rosadas CUELLO: Adenopatías palpables supraclaviculares, y a lo largo del esternocleidomastoideo bilateral, predominio izquierdo, además con adenopatía preauricular prominente, dolorosa izquierda. ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias palpables EXTREMIIDADES: Símétricas

Análisis:

Paciente de 29 años con diagnóstico de VIH (2016) en manejo con TARV. Actualmente en contexto de tuberculosis pulmonar, en quien se inició terapia RIPE de forma escalonada por historia de toxicidad hepática asociado a tratamiento, se reinició de forma escalonada, en el momento en manejo con Etambutol, pirazinamida y rifampicina iniciada el día de ayer con adecuada tolerancia, tiene pendiente realización de TAC de cuello, tórax, y abdomen por adenopatías palpables en cadenas cervicales predominantemente izquierdo. Continuaremos atentos a evolución clínica del paciente. Se explica y se solucionan dudas, refiere a comprender.

Fecha: 14/04/2022: 11:06:32, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS: 1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A: 1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022) 1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO 3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS 4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA 5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Subjetivo:

ME SIENTO BIEN

Objetivo:

OBJETIVO PACIENTE EN CAMA, POSICIÓN DECÚBITO SUPINO, SIN ACOMPAÑANTE, LUCE TRANQUILA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. SIGNOS VITALES FC: 80 LPM PA: 100/60 MMHG SATO2: 96% EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, YA LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH (2016) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, SE REINICIO DE FORMA ESCALONADA, EN EL MOMENTO EN MANEJO CON ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA Y RIFAMPICINA INICIADA EL DÍA DE AYER CON ADECUADA TOLERANCIA, SE RECIBE INFORME DE ESTUDIOS TOMOGRAFICOS QUE MUESTRAN: TAC DE CUELLO: PRESENCIA DE ADENOMEGALIAS EN EL HEMICUELLO IZQUIERDO EN SEGMENTO II, ASI COMO PEQUEÑO GANGLIO EN LA REGION SUPRACLAVICULAR IZQUIERDA. TAC DE TORAX: LOS CAMPOS PULMONARES MUESTRAN MULTIPLES OPACIDADES MICRONODULARES DIFUSAS BILATERALES ASI COMO OPACIDADES RETICULARES DIFUSAS POR PROBABLES LESIONES SECUNDARIAS. PRESENCIA DE NODULOS SOLIDOS EN LA PLEURA EN AMBOS CAMPOS PULMONARES POR LESIONES SECUNDARIAS. TAC DE ABDOMEN: NORMAL. SE SOLICITA VALORACION POR CIRUGIA GENERAL Y CIRUGIA DE TORAX. CONTINUAREMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE. SE EXPLICA Y SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Fecha: 15/04/2022: 11:26:07, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere pasar la noche tranquila.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, sin signos de dificultad respiratoria.

SIGNOS VITALES

FC 90 PA: 100/60 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, YA LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH (2016) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, SE REINICIO DE FORMA ESCALONADA, EN EL MOMENTO EN MANEJO CON ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA Y RIFAMPICINA, ADECUADA TOLERANCIA, POR HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN TOMOGRAFÍAS SE SOLICITÓ VALORACIÓN POR CIRUGÍA DE TÓRAX QUIEN INDICÓ BIOPSIA DE FÁCIL ACCESO A NIVEL CERVICAL, YA FUE VALORADA POR CIRUGÍA GENERAL QUIEN PROGRAMÓ, A ESPERA DE REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO. CONTROL PARACLÍNICO EVIDENCIA PERSISTENCIA DE ASCENSO DE ALT DE 65 A 109, POR EL MOMENTO CONTINUAREMOS EN OBSERVACIÓN Y CON CONTROL PARACLÍNICO, EL CUAL SE SOLICITA PARA EL DÍA DE MAÑANA. SE EXPLICA Y SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Fecha: 16/04/2022: 12:13:37, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

2. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

3. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

4. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FIEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA 110/60 FC 94 TEMP 36,2 GRADOS FR 19 SATO2 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW.

PARACLINICOS

15/04/22:

BT 0.21 BD 0.13 BI 0.08 AST 97 ALT 109 BUN 18 CREA 0.72

LEU 3.70 NEU 2.37 LINF 0.81 HB 10.9 HTO 37.4 VCM 87.9 HCM 25.6 CCMH 29.1 IDE 18.8 PLAQ 285

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA, CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. PACIENTE SE ENCUENTRA EN MANEJO CON TERAPIA RIPE ESCALONADA CON ETAMBUTOL FI 31.03.2022. Y PIRAZINAMIDA FI 05/04/2022, CON REPORTE DE PARACLINICOS DE FUNCION HEPÁTICA ALTERADOS, SIN EMBARGO NO SUPERAN MÁS DE 5 VECES EL NIVEL DE REFERENCIA POR LO CUAL CONTINUA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

TON TERAPIA RIPE. EL DIA DE HOY SE SOLICITAN PARA CLÍNICOS DE CONTROL, PARA Estricta Vigilancia de la función hepática por lo que se solicita AST, ALT, BT, BD, BI. PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA DE GANGLIO CERVICAL, VALORACIÓN POR ANESTESIOLOGÍA, DE MOMENTO CONTINUA HOSPITALIZADA A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA BIOPSIA DE GANGLIO CERVICAL E INTERCONSULTAR NUEVAMENTE A CIRUGÍA DE TÓRAX CON RESULTADO DE BIOPSIA (A FUTURO) SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 17/04/2022: 10:19:50, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE FEMENINO DE 29 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO

2. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

3. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO

4. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, NIEGA FIEBRE, EMESIS Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA 100/60 FC 97 TEMP 35,0 GRADOS FR 16 SATO2 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, ALERTA, ORIENTADA EN LAS 3 ESFERAS, MUCOSAS HÚMEDAS, MUCOSA ORAL SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SE PALPAN GANGLIOS SUPRACLAVICULARES INFLAMADOS, MOVIBLES. TÓRAX EXPANSIBLE SIMÉTRICO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO CON CRÉPITOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE, SIN DOLOR A LA PALPACIÓN PROFUNDA GENERALIZADA, SE PALPAN GANGLIOS INGUINALES INFLAMADOS. EXTREMIDADES SIMÉTRICAS, PULSOS PRESENTES. SNC SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO, GLASGOW. PARA CLÍNICOS

16/04/2022 AST: 64, ALT: 88, BILITOTAL 2.09, :BD: 0.18, BI:1.91

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE VIH CON CRITERIOS DEFINITORIOS DE SIDA, HOSPITALIZADA EN EL CONTEXTO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA ASOCIADO A INFILTRADOS RETICULARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. ACTUALMENTE PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, POR MOMENTOS NO PRESENTA PICOS FEBRILES, HIDRATADA CON BUEN PATRÓN RESPIRATORIO. PACIENTE SE ENCUENTRA EN MANEJO CON TERAPIA RIPE ESCALONADA CON ETAMBUTOL FI 31.03.2022. Y PIRAZINAMIDA FI 05/04/2022. SE REPORTAN PARA CLÍNICOS DE CONTROL PREVIAMENTE SOLICITADOS, EN DONDE SE OBSERVAN TRANSAMINASAS ELEVADAS, SIN EMBARGO CON LIGERO DESCENSO CON RESPECTO A LA PREVIA BILIRRUBINA TOTAL ELEVADA A EXPENSA DE LA INDIRECTA. CONTINUA PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA DE GANGLIO CERVICAL, VALORACIÓN POR ANESTESIOLOGÍA, DE MOMENTO CONTINUA HOSPITALIZADA A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA BIOPSIA DE GANGLIO CERVICAL E INTERCONSULTAR NUEVAMENTE A CIRUGÍA DE TÓRAX CON RESULTADO DE BIOPSIA (A FUTURO). SE LE EXPLICA CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA

Fecha: 18/04/2022: 12:24:22, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

DIAGNÓSTICOS.

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO

5. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en buenas condiciones generales, pasa la noche tranquila, niega alzas térmicas, niega otra sintomatología.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición decúbito supino, sin acompañante, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria.

SIGNOS VITALES

FC:96 lpm PA: 100/70 mmHg SATO2: 99%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS

CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES

EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

PARA CLÍNICOS:

16/04/2022 AST: 64, ALT: 88, BILITOTAL 2.09, :BD: 0.18, BI:1.91

15/04/22:

BT 0.21 BD 0.13 BI 0.08 AST 97 ALT 109 BUN 18 CREA 0.72

LEU 3.70 NEU 2.37 LINF 0.81 HB 10.9 HTO 37.4 VCM 87.9 HCM 25.6 CCMH 29.1 IDE 18.8 PLAQ 285

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH (2016) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, EN EL MOMENTO EN MANEJO CON ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA Y RIFAMPICINA ADECUADA TOLERANCIA, POR HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN TOMOGRAFÍAS SE SOLICITÓ VALORACIÓN POR CIRUGÍA DE TÓRAX QUIEN INDICÓ BIOPSIA DE FÁCIL ACCESO A NIVEL CERVICAL, YA FUE VALORADA POR CIRUGÍA GENERAL QUIEN PROGRAMÓ, A ESPERA DE REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO. PACIENTE EN EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE, CON MEJORÍA DE AMINOTRANSFERASAS, SE SOLICITA CONTROL PARA CLÍNICO PARA VALORAR EVOLUCIÓN. POR EL MOMENTO, NO SE REALIZA OTRA MODIFICACIÓN EN TRATAMIENTO, CONTINUAREMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA. SE EXPLICA Y SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER

Fecha: 19/04/2022: 11:05:50, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

Problema:

1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en buenas condiciones generales, pasa la noche tranquila, niega dolor, niega alzas térmicas, niega otra sintomatología.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en posición de bipedestación, sin acompañante, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria.

SIGNOS VITALES:

FC: 80 lpm PA: 90/60 mmHg SATO2: 96%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES:

CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS

CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES

EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

PARACLÍNICOS:

18/04/22 ALT:66 AST:46 CREA:0.59 BUN:16 BT:015 BD 0.13 BI 0.02

16/04/2022 AST: 64, ALT: 88, BILITOTAL 2.09, :BD: 0.18, BI:1.91 15/04/22: BT 0.21 BD 0.13 BI 0.08 AST 97 ALT 109 BUN 18 CREA 0.72 LEU 3.70 NEU 2.37 LINF

0.81 HB 10.9 HTO 37.4 VCM 87.9 HCM 25.6 CCMH 29.1 IDE 18.8 PLAQ 285

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO. EN TRATAMIENTO CON ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA Y RIFAMPICINA, ADECUADA TOLERANCIA, PARA CLÍNICOS DE CONTROL DEL DÍA DE AYER 18/04/2022 CON AMINOTRANFERASAS DENTRO DE LÍMITES NORMALES. POR OTRO LADO, EN CONTEXTO DE ADENOPATÍAS CERVICALES IZQUIERDAS Y LESIONES SUBPLERUALES DE CARACTERÍSTICAS SÓLIDAS, EN SEGUIMIENTO EN CONJUNTO CON EL GRUPO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CIRUGÍA GENERAL, QUIEN POR FACILIDAD DE ACCESO DIAGNÓSTICO SERÁ LLEVADA A BIOPSIA GANGLIO CERVICAL PROBABLEMENTE A REALIZAR EL DÍA VIERNES 22/04/2022. POR EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE, CONTINUAREMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA PACIENTE. SE EXPLICA CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Fecha: 20/04/2022: 12:08:23, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS:

1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en buenas condiciones generales

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, sin acompañante, luce tranquila.

SIGNOS VITALES

FC 97 lpm PA 100/70 mmHg SATO2: 98%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES: CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

PARACLÍNICOS: 18/04/22 ALT:66 AST:46 CREA:0.59 BUN:16 BT:015 BD 0.13 BI 0.02 16/04/2022 AST: 64, ALT: 88, BILITOTAL 2.09, :BD: 0.18, BI:1.91 15/04/22: BT 0.21 BD 0.13 BI 0.08 AST 97 ALT 109 BUN 18 CREA 0.72 LEU 3.70 NEU 2.37 LINF 0.81 HB 10.9 HTO 37.4 VCM 87.9 HCM 25.6 CCMH 29.1 IDE 18.8 PLAQ 285

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO. EN TRATAMIENTO CON ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA Y RIFAMPICINA, ADECUADA TOLERANCIA, POR DOCUMENTACIÓN PREVIA DE TRANSMISITIS APARENTEMENTE ASOCIADA AL USO DE ISONIAZIDA, SE DECIDE INICIO DE LEVOFLOXACINA, ADICIONALMENTE SE AJUSTA ESQUEMA TARV Y SE INICIA MANEJO CON DOLUTEGRAVIR EL CUAL NO HA DEMOSTRADO GENERAR ALTERACIÓN DE PRUEBAS HEPÁTICAS. PACIENTE EN EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE, CON ÚLTIMO CONTROL PARA CLÍNICO DEL 18/04/2022 CON AMINOTRANFERASAS DENTRO DE LÍMITES NORMALES. TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA DE GANGLIO CERVICAL PROBABLEMENTE A REALIZAR EL 22/04/2022. CONTINUAREMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE. SE EXPLICA Y SE SOLUCIONAN DUDAS.

Fecha: 21/04/2022: 12:17:07, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS:

1. SINDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCION POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

- 1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO
3. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS
4. SÍNDROME ANEMICO MODERADA
5. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere que se siente en buenas condiciones generales, niega dolor, niega otros síntomas

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en habitación, en posición de sedestación, luce tranquila.

SIGNOS VITALES

FC: 98 lpm PA: 100/60 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES:

CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

PARACLÍNICOS: 18/04/22 ALT:66 AST:46 CREA:0.59 BUN:16 BT:015 BD 0.13 BI 0.02 16/04/2022 AST: 64, ALT: 88, BILITOTAL 2.09, :BD: 0.18, BI:1.91 15/04/22: BT 0.21 BD 0.13 BI 0.08 AST 97 ALT 109 BUN 18 CREA 0.72 LEU 3.70 NEU 2.37 LINF 0.81 HB 10.9 HTO 37.4 VCM 87.9 HCM 25.6 CCMH 29.1 IDE 18.8 PLAQ 285.000

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO. EN TRATAMIENTO CON ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA Y RIFAMPICINA, ADECUADA TOLERANCIA, POR DOCUMENTACIÓN PREVIA DE TRANSMISIÓN APARENTEMENTE ASOCIADA AL USO DE ISONIAZIDA. EL DÍA DE AYER SE INDICÓ TRATAMIENTO CON LEVOFLOXACINA EL CUAL NO SE INICIÓ POR NO DISPONIBILIDAD, SE REALIZA CAMBIO DE PRESENTACIÓN A VÍA ENDOVENOSA. PACIENTE EN EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE, EL DÍA DE MAÑANA 22/04/2022 SE REALIZARÁ CONTROL PARACLÍNICO Y TIENE PROPUESTO SER LLEVADO A BIOPSIA DE GANGLIO CERVICAL PROBABLEMENTE. CONTINUAREMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE. SE EXPLICA Y SE SOLUCIONAN DUDAS.

Fecha: 22/04/2022: 12:28:14, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS.

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

2. ADENOMEGALIAS CERVICALES EN ESTUDIO

3. LESIONES SUBPLEURAL EN ESTUDIO

4. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

5. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Refiere sentirse en buenas condiciones generales

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria

SIGNOS VITALES

FC: 98 lpm PA: 100/60 mmHg SATO2: 978%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS

CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

20/04/2022 TP 9.9, INR 0.9, TTP 30.9, BT 0.13, BD 0.12, BI 0.01, ALT 59, AST 52, CREA 0.86, BUN 17

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, EL CUAL SE REINICIO Y HASTA EL MOMENTO CON ADECUADA TOLERANCIA SE DECIDIÓ NO INICIO DE ISONIAZIDA Y SE INDICÓ LEVOFLOXACINA TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA CERVICAL, EL DÍA DE HOY SE SOLICITA CONTROL PARACLÍNICO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Fecha: 23/04/2022: 11:55:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A:

1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNOSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022)

1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO

2. ADENOMEGALIAS CERVICALES EN ESTUDIO

3. LESIONES SUBPLEURAL EN ESTUDIO

4. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS

5. SÍNDROME ANEMICO MODERADA

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en buenas condiciones general. Niega alzas térmicas, niega otra sintomatología. Manifiesta síntomas de tristeza y llanto fácil relacionados con situación de salud actual, y preocupación por su familia.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, luce tranquila, sin signos de dificultad respiratoria.

SIGNOS VITALES

FC: 80 lpm PA:100/80 mmHg SATO2: 96%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

PARACLÍNICOS

20/04/2022 TP 9.9 , INR 0.9 , TTP 30.9 , BT 0.13 , BD 0.12 , BI 0.01 , ALT 59, AST 52, CREA 0.86, BUN17

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, EL CUAL SE REINICIO Y HASTA EL MOMENTO CON ADECUADA TOLERANCIA, SE DECIDIÓ NO INICIO DE ISONIAZIDA Y SE INDICÓ LEVOFLOXACINA, EN EL MOMENTO CON ADECUADA TOLERANCIA, PARACLÍNICOS DE CONTROL DENTRO DE LÍMITES ACEPTABLES, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA GANGLIOS CERVICALES IZQUIERDOS, EL CUAL PROBABLMENTE SERÁ REALIZADO EL 25/04/2022. POR EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE. SE SOLICITA VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LA ENFERMEDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REIFERE COMPRENDER.

Fecha: 24/04/2022: 11:03:10, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: CESAR AUGUSTO VERGARA VERGARA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Problema:

síndrome constitucional secundario:

1.1 Virus de la inmunodeficiencia humana 22/02/22

1.2 tuberculosis pulmonar

1.3 Adenocarcinomas cervicales

1.4 Lesión subpleural en estudio

Toxicidad por antituberculosos

Síndrome anémico moderado

Déficit absoluto de hierro

Subjetivo:

paciente quien refiere regular estado general, picos febriles. niega dolor, náuseas o episodios eméticos.

Objetivo:

Paciente en regulares condiciones generales, alerta, orientada cabeza y cuello: cuello simétrico, móvil sin adenopatías regionales. cardiopulmonar: tórax simétrico ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni otros patológicos. murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares, no sobreagregados abdomen blando, dolor a la palpación en epigastrio, mesogastrio, masa palpable a nivel de epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. extremidades simétricas, no edema, llenado capilar menor a dos segundos. neurológico sin déficit sensitivo, ni motor. glasgow 15/15.

Paraclínicos:

22/04/22: HB 9.8, HTO 33.2, LEU 3.26, PLAQ 209, TP 11.7, TPT 26.9, BUN 17, CREAT 0.62, AST 61, ALT 71, BT 0.24, BD 0.18, BI 0.06.

Análisis:

Paciente femenina de 29 años de edad, con diagnósticos previamente descritos en contexto de adenomegalias cervicales. Actualmente hemodinámicamente estable, afebril, tolerando oxígeno ambiente. Paciente conocida por nuestro servicio, a la espera de realización de biopsia de ganglios cervicales izquierdos programada para el 25/04/22. Pendiente valoración por psicología, cultivo MTB y BK. Se reciben paraclínicos en donde se evidencia anemia moderada, marcada leucopenia. Continúa manejo de patologías de base por parte del servicio de medicina interna. Se le explica conducta a seguir a paciente y familiar el cual refiere entender y aceptar.

Fecha: 24/04/2022: 12:43:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS 1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A: 1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022) 1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO 2. ADENOMEALIAS CERVICALES EN ESTUDIO 3. LESIONES SUBPLEURAL EN ESTUDIO 4. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS 5. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO 6. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE EN BUENAS CONDICIONES GENERAL. NIEGA ALZAS TÉRMICAS, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGÍA. MANIFIESTA SÍNTOMAS DE TRISTEZA Y LLANTO FÁCIL RELACIONADOS CON SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL, Y PREOCUPACIÓN POR SU FAMILIA

Objetivo:

TA:60/90 MMHG FC 98 T: 36.3°C FR 20 RPM SAT 96% OXÍGENO AMBIENTE

PACIENTE EN CAMA, EN POSICIÓN DE SEDESTACIÓN, LUCE TRANQUILA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. SIGNOS VITALES FC: 80 LPM PA:100/80 MMHG SATO2: 96% EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PRODOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS

PARACLÍNICOS

22/04/2022

Hemograma Leu: 3260 Neu: 1630 Linf 1040 Hb 9.8 Hcto: 33.2% VCM84.9 HCM25 PLT 209.000 PT 10.1 INR 0.9 PTT 32.1 BUN 17 Creatinina 0.62 AST 61 ALT 71 BT 0.24 BD 0.18 BI 0.06

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADO A TRATAMIENTO, EL CUAL SE REINICIO Y

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS

HASTA EL MOMENTO CON BUENA TOLERANCIA, SE DECIDIÓ NO INICIO DE ISONIAZIDA Y SE INDICÓ LEVOFLOXACINA, EN EL MOMENTO CON ADECUADA TOLERANCIA. PARA CLÍNICOS DE CONTROL DENTRO DE LÍMITES ACEPTABLES, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA GANGLIOS CERVICALES IZQUIERDOS, EL CUAL PROBABLMENTE SERÁ REALIZADO EL 25/04/2022. POR EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE. SE SOLICITA VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LA ENFERMEDAD. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMAR CAMBIOS.

Fecha: 25/04/2022: 12:46:36, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS 1. SÍNDROME CONSTITUCIONAL SECUNDARIO A: 1.1 INFECCIÓN POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO (CONTEO DE CD4 267 - E: C2 22/02/2022) 1.2 TUBERCULOSIS PULMONAR DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO 2. ADENOMEGALIAS CERVICALES EN ESTUDIO 3. LESIONES SUBPLEURALES EN ESTUDIO 4. TOXICIDAD POR ANTITUBERCULOSOS 5. SÍNDROME ANÉMICO MODERADO 6. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE EN BUENAS CONDICIONES GENERAL. NEGAAZAS TÉRMICAS, NEGAA OTRA SINTOMATOLOGÍA MANIFIESTA SÍNTOMAS DE TRISTEZA Y LLANTO FÁCIL RELACIONADOS CON SITUACIÓN DE SALUD ACTUAL, Y PREOCUPACIÓN POR SU FAMILIA.

Objetivo:

TA: 120/80 MMHG FC 115 T: 36.3°C FR 18 RPM SAT 96% OXÍGENO AMBIENTE

PACIENTE EN CAMA, EN POSICIÓN DE SEDESTACIÓN, LUCE TRANQUILA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA: MUCOSAS HÚMEDAS Y ROSADAS CUELLO: ADENOPATÍAS PALPABLES SUPRACLAVICULARES, Y A LO LARGO DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO BILATERAL, PREDOMINIO IZQUIERDO, ADEMÁS CON ADENOPATÍA PREAURICULAR PRONINENTE, DOLOROSA IZQUIERDA ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS.

Análisis:

PACIENTE DE 29 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH C2 (2022) EN MANEJO CON TARV. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, EN QUIEN SE INICIÓ TERAPIA RIPE DE FORMA ESCALONADA POR HISTORIA DE TOXICIDAD HEPÁTICA ASOCIADA A TRATAMIENTO, EL CUAL SE REINICIÓ Y HASTA EL MOMENTO CON BUENA TOLERANCIA, SE DECIDIÓ NO INICIO DE ISONIAZIDA Y SE INDICÓ LEVOFLOXACINA, EN EL MOMENTO CON ADECUADA TOLERANCIA. PARA CLÍNICOS DE CONTROL DENTRO DE LÍMITES ACEPTABLES, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE BIOPSIA GANGLIOS CERVICALES IZQUIERDOS, EL CUAL PROBABLMENTE SERÁ REALIZADO EL 25/04/2022. POR EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE. SE SOLICITA BRONCOSCOPÍA POR ADENOMEGALIAS CERVICALES EN ESTUDIO Y LESIONES SUBPLEURALES. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A SEGUIR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMAR CAMBIOS.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

ASOCIADAS A TBC

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Egreso: 26/04/2022 12:18

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A150 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCÓPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO

Diagnóstico Relacionado 1: B24X: ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:

Tratamiento Farmacológico:

- ALTA MÉDICA

- ETAMBUTOL TAB 275 MG

ADMINISTRAR 2 TABLETAS DÍA (FI: 31/03/22)

- PIRAZINAMIDA TAB 400 MG

ADMINISTRAR 2 TABLETAS AL DÍA (FI: 07/04/2022)

- RIFAMPICINA TAB 300 MG

TOMAR 2 TAB VO DÍA (FI: 13/04/22)

- LEVOFLOXACINA 750 MG

TOMAR VÍA ORAL CADA 12 HORAS (FI: 22/04/22)

- PIRIDOXINA 50 MG

TOMAR 1 TAB VO CADA DÍA, POR 30 DÍAS #30

- ABACAVIR SULFATO Y LAMIVUDINA TAB 600MG/300MG

TOMAR 1 TAB DÍA, POR 30 DÍAS #30

- DOLUTEGRAMR TAB 50 MG VO

TOMAR 1 TAB VO DÍA, POR 30 DÍAS #30

- OMEPRAZOL 20 MG

TOMAR 1 TAB VO CADA DÍA, POR 30 DÍAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:55:56 p. m.

Admisión: AD716477

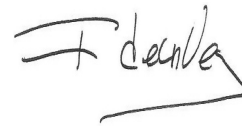
Administradora: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA - DADIS

Paciente: GLADYS MARIA MEJIA ALEMAN

EPICRISIS**Recomendaciones Adicionales:**

INGRESAR AL PROGRAMA DE TBC DE SU EPS

Aplica Cuidados de Enfermería: No



FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO

INFECTOLOGIA

CC.73099305 - RM.CC:73099305 - RM:1414